

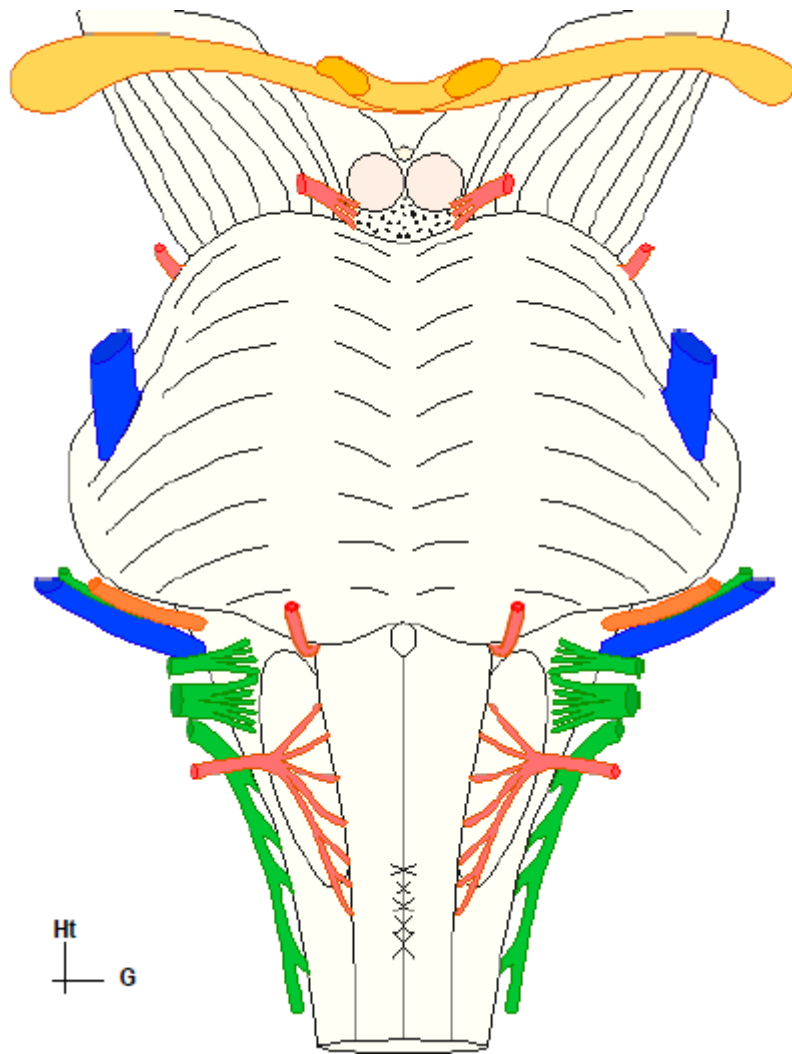
Service de médecine interne
EH Didouche Mourad
Constantine

Anomalies secondaires à des lésions du IX, X, XI, XII

Dr M.S. Djebaili
Maître assistant en Médecine interne;
Service de médecine interne EH DM;
Laboratoire de recherche Diab-Suc;
Univeristé 3, Constantine.

Objectifs :

- Classer les nerfs crâniens selon leur propriété
- Examiner les nerfs crâniens
- Identifier les anomalies de chaque nerf crâniens



12 paires de nerfs crâniens

I : n. olfactif

II : n. optique

III : n. oculomoteur

IV : n. trochléaire

V : n. trijumeau

VI : n. abducens

VII : n. facial

VIIb : n. intermédiaire

VIII : n. cochléo-vestib.

IX : n. glosso-pharyngien

X : n. vague

XI : n. accessoire

XII : n. hypoglosse

Classification

Sensitifs :

Nerfs olfactif I

Nerf optique II

Nerf vestibulo-cochléaire VIII

Moteurs :

Nerf oculomoteur III

Le pathétique IV

Moteur abducens VI

Le spinal XI

Le grand hypoglosse XII

Mixte :

Trijumeau V

Facial VII

Glosso-Pharyngien IX

Vague X

Anomalies liées à une lésions du nerf glosso-pharyngien (IX)

Nerf glosso-pharyngien (IX): est un nerf mixte, il contient des fibres motrices, sensibles , sensorielles et végétatives.

- Fonction motrice: dont les fibres ont une origine et une distribution communes avec celles du X , et contribuent à l'innervation du voile du palais et des muscles du pharynx.
- Fonction sensitive: la sensibilité du pharynx, amygdales, les piliers vélares (voile du palais), du 1/3 postérieur de la langue et de l'oreille moyenne (partie postérieurs du tympan, conduit auditif externe).
- Fonction sensorielles: la sensibilité gustative du 1/3 postérieur de la langue (le gout)
- Fonction végétative: innerve la glande parotide pour la sécrétion salivaire

Examen clinique : la composante motrice du IX, ne peut être testée qu'avec le X (en raison du partage de l'anastomose provenant du X) .

Tester le reflexe nauséeux: c'est un examen pénible et ne doit être pratiqué qu'en cas de suspicion d'atteinte des nerfs crâniens inférieurs, appuyer fermement le bout de l'abaisse-langue , successivement sur chacune des fosses amygdaliennes (IX pour la composante sensitive, X pour la composante motrice) , la réponse normale est l'ascension de la luette, avec contraction du palais des 2 cotés, voire un vomissement, si atteinte du IX, on aura une diminution ou abolition du réflexe nauséeux.

La composante sensitive du réflexe est testée lors du toucher du pharynx de chaque coté , on demande au patient si la sensation est identique .

Etude clinique : Une lésions du glosso-pharyngien entraine:

- Une agueusie du tiers postérieur de la langue
- Une hypoesthésie de l'amygdale, du voile et du pharynx
- Une gêne à la déglutition
- Une abolition unilatérale du reflexe nauséeux

La névralgie du IX:

C'est un accès douloureux , il a les caractéristiques suivantes :

- Sièges: unilatéral , oreille, la base de la langue, la partie postérieure de la gorge (en particulier la fosse amygdalienne) et sous l'angle mandibulaire.
- Irradiation : le long du cou .
- Intensité: modérée.
- Durée : varie de quelques secondes à 2 minutes, des périodes de rémission sont possibles .
- Facteurs déclenchants : salivation , mastication , toux et le fait de tirer la langue.
- Signes accompagnateurs: trouble du rythme cardiaque, syncope par stimulation du X,
- L'examen clinique : le réflexe nauséeux est abolis .

Anomalies liée à l'atteinte du X

Nerf pneumogastrique ou le vague : est nerf mixte avec des fonctions végétatives importantes.

- Fonction motrice: de tous les muscles du pharynx, larynx, du voile du palais , il intervient dans le temps pharyngien de la déglutition.
- Fonction végétative : il est hypotenseur et cardiomodérateur, il intervient dans la régulation de certaines glandes digestives et salivaires .
- Fonction sensitive: sensibilité de la base de la langue (avec le IX), de l'épiglotte, du larynx.

Etude clinique

A/ Paralyse vélo-palatine:

- 1 Unilatérale : le voile du palais est asymétrique avec déviation du voile et de la luette du côté sain et défaut d'ascension du voile du côté paralysé , quand on fait prononcer au patient la lettre « A », c'est le signe du Rideau
- 2 Bilatérale: la voix est sourde et nasonnée, le voile ne se contracte pas, reflux de liquide par le nez.

B/ Paralyse pharyngée:

Un trouble de la déglutition sévère, en cas d'atteinte bilatérale , les aliments refluent par le nez.

Il est important de tester la déglutition avant d'autoriser le malade de s'alimenter , en raison du risque immédiat de fausses routes avec inhalation de corps étranger , qui peut obstruer les voies aériennes et provoquer une détresse respiratoire , ou à distance une surinfection pulmonaire ou une atélectasie .

L'évaluation apprécie la sensibilité de l'oropharynx qu'il faut toucher

- À l'aide d'un abaisse-langue le voile du palais , la langue, et la paroi pharyngée postérieure , en demandant si le patient ressent la stimulation et en recherchera également le réflexe nauséeux , on teste ensuite la déglutition de façon progressive avec un aliment sans risque, tel que, l'eau gélifiée puis gazeuse (qui stimule la déglutition), puis l'eau plate , observer le patient après chaque ingestion et lui demander de parler .

C / Paralysie laryngée :

- a. unilatérale : une dysphonie avec une voix bitonale .
- b. bilatérale : une aphonie totale , à l'examen les cordes vocales sont
Immobilisées

Signes végétatifs:

- Tachycardie, accélération du pouls avec une instabilité lors du changement de position
- Irritation gastrique et œsophagienne responsable de nausée et de vomissements, diarrhée .
- Dyspnée causée par des spasmes bronchiques .

Anomalies liées à l'atteinte du Nerf XI (spinal)

Seul le spinal médullaire ou le spinal externe sera envisagé, c'est un nerf exclusivement moteur, qui innerve le sterno-cléido-mastoïdien (SCM) et le trapèze.

Etude clinique :

- Examen du SCM (muscle fléchisseur et rotateur de la tête): on demande au patient de tourner la tête contre une résistance appliquée sur le menton, le SCM fait tourner la tête du côté opposé, en se raccourcissant, palper le bombement du SCM.

La lésion du XI, entraîne un déficit de la rotation de la tête du côté opposé.

Ou on demande au patient de fléchir sa tête en avant (antéflexion), on s'oppose en prenant appui sur le menton, si lésion, pas de contraction du SCM.

Le trapèze (muscle élévateur des épaules):

Examiné en demandant au patient de lever les épaules ,
d'abord librement puis en lui opposant une résistance, si
lésion:

- Le creux sus claviculaire est plus profond.
- L'angulaire de l'omoplate fait saillie .
- Le moignon de l'épaule abaissé .
- L' épaule ne peut être haussée et se déplace en avant.
- L'élévation du bras latéralement est souvent incomplète
avec décollement de l'omoplate qui s'accentue lors du
mouvement .



**Saillie de l'angulaire
de l'omoplate**

Anomalies liées à une lésion du Nerf XII (grand hypoglosse)

Nerf exclusivement moteur, chaque nerf innerve une hémilangue, permettant à la langue d'assurer toutes ses fonctions dans la mastication, la déglutition et la phonation.

Etude clinique:

Examiner la langue dans sa position naturelle sur le plancher buccal, vérifier son volume puis demander au patient de tirer sa langue (une légère déviation est fréquente chez le sujet sain), pour évaluer la force musculaire, demander au patient d'appuyer avec sa langue sur sa joue, en lui opposant une résistance, vérifier enfin les mouvements latéraux.

Une lésion unilatérale : entraîne une paralysie de l'hémilangue, qui est amyotrophique (amincie) avec trouble de la déglutition, de la mastication et de la parole, la langue tirée (en protraction) est déviée vers le côté paralysé, la langue rentrée, est déviée du côté sain.



Merci pour votre attention